

약제 요양급여의 적정성 평가결과

bimekizumab 160mg

(빔젤릭스오토인젝터주(비메키주맵), 한국유씨비제약(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1오토인젝터 중 bimekizumab 160mg

☐ 효능·효과

- 광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 성인 환자의 중등도에서 중증의 판상 건선의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2025년 제2차 약제급여평가위원회: 2025년 2월 6일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2024년 11월 26일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 성인 환자의 중등도에서 중증의 판상 건선의 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하나 대체약제 대비 소요 비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■%) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 성인 환자의 중등도에서 중증의 판상 건선의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 risankizumab, guselkumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 신청품은 판상 건선 환자에게 사용되는 IL-17A, IL-17F 이중 억제제 (dual-inhibitor)로 소개됨.
- 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에서 신청품은 methotrexate, cyclosporine 등 기존의 전신치료제에 반응이 없거나 금기이거나 내약성이 없는 중등도-중증의 판상 건선 환자에게 사용가능한 생물학적 제제 중 하나로써 권고됨.
- [BE READY, 위약대조 3상]⁶⁾ 18세 이상 중등도-중증 만성 판상 건선 성인환자 (n=435)를 대상으로 신청품군과 위약군에 4:1로 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,
 - 16주 PASI 90 달성률: 신청품군 91%, 위약군 1% (p<0.0001)
 - 16주 IGA 0/1 달성률: 신청품군 93%, 위약군 1% (p<0.0001)
- [BE SURE, adalimumab대조 3상]⁷⁾ 18세 이상 중등도-중증 만성 판상 건선 성인환자

(n=478)를 대상으로 신청품군(4주요법), 신청품군(4주/8주요법)⁸⁾, adalimumab군 1:1:1 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,

- 16주 PASI 90 달성률: 신청품군 통합⁹⁾ 86.2%, adalimumab군 47.2% ($p<0.001$)
- 16주 IGA 0/1 달성률: 신청품군 통합¹⁰⁾ 85.3%, adalimumab군 57.2% ($p<0.001$)

- [BE VIVID, ustekinumab 및 위약대조 3상]¹¹⁾ 18세 이상 중등도-중증 만성 판상 건선 성인환자(n=567)를 대상으로 신청품군과 ustekinumab군, 위약군에 4:2:1로 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,

- 16주 PASI 90 달성률: 신청품군 85%, ustekinumab군 50%, 위약군 5% ($p<0.0001$)
- 16주 IGA 0/1 달성률: 신청품군 84%, ustekinumab군 53%, 위약군 5% ($p<0.0001$)

- [BE RADIANT, secukinumab대조 3상]¹²⁾ 18세 이상 중등도-중증 만성 판상 건선 성인환자(n=743)를 대상으로 신청품군과 secukinumab군에 1:1로 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,

- 16주 PASI 100 달성률: 신청품군 61.7%, secukinumab군 48.9% ($p<0.001$)

- [네트워크 메타분석①]¹³⁾ 성인 중등도-중증 판상 건선 환자의 유도기간(8-24주) 분석 결과 PASI 90 달성률은

- 신청품과 infliximab, ixekizumab, risankizumab간 유의한 차이가 없었으며, apremilast, deucravacitinib, adalimumab, etanercept, ustekinumab, guselkumab, secukinumab 대비 신청품에서 유의하게 높았음.

- [네트워크 메타분석②]¹⁴⁾ 성인 중등도-중증 판상 건선 환자의 장기(48-56주) 분석결과, PASI 75, PASI 90 및 PASI 100 달성률은

- 신청품과 risankizumab, guselkumab, ixekizumab간 유의한 차이가 없었으며, adalimumab, etanercept, ustekinumab, secukinumab 대비 신청품에서 유의하게 높았음.

- 관련 학회¹⁵⁾에 따르면 건선은 악화와 호전을 장기간 반복적으로 경험하는 난치성 질환으로, 다양한 치료옵션이 있음에도 여전히 효과적이고 새로운 기전의 치료제에 대한 요구도가 높은 상황임. 신청품은 IL-17A와 IL-17F를 동시에 억제하는 최초의 건선치료제이며, 위약 및 활성대조군(ustekinumab, adalimumab, secukinumab) 대비 우월성 및 안전성을 입증하여 가이드라인에서 권고되므로 급여가 필요하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 현행 급여기준 및 신청품의 설정된 급여기준(안), 임상진료지침, 학회의견, 약제 특성 등을 고려하여 adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, guselkumab, risankizumab을 대체약제로 선정함.

- 신청품의 1일 소요비용(■■■■원)은 대체약제 가중 1일 소요비용(■■■■원) 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 신청품의 단위비용 및 약가협상생략 기준금액¹⁶⁾은 ■■■■원임.

○ 재정 영향¹⁷⁾

1) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량¹⁸⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도 약 ■■■억, 3차년도 약 ■■■억이고, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액²⁰⁾은 1차년도 약 ■■■억, 3차년도 약 ■■■억 증가할 것으로 예상됨.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격을 기준으로 제약사 제출 예상사용량 적용 시 신청품 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■억, 3차년도 약 ■■■억이고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음²¹⁾.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 8개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본, 캐나다) 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) Jean L, et al. Dermatology. 5th edition. Elsevier; 2024
 - 2) Sewell MJ, et al. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14th edition. McGraw-Hill Education; 2023
 - 3) Goldman L, et al. Goldman-Cecil Medicine. 27th edition. Elsevier; 2023
 - 4) Nast A, et al. EuroGuiDerm Guideline for the systemic treatment of psoriasis vulgaris. European Dermatology Forum. Revised version March 2024.
 - 5) Smith CH, et al. British Association of Dermatologists guidelines for biologic therapy for psoriasis 2023: a pragmatic update. Br J Dermatol. 2024;190(2):270-2.
 - 6) Gordon KB, et al. Bimekizumab efficacy and safety in moderate to severe plaque psoriasis (BE READY): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdrawal phase 3 trial. Lancet 2021;397:475-86.
 - 7) Warren RB, et al. Bimekizumab versus Adalimumab in Plaque Psoriasis. N Engl J Med. 2021;385:130-41.
 - 8) 신청품군(4주요법)은 신청품을 4주간격으로 투여함. 신청품군(4주/8주요법)은 신청품을 0-16주까지 4주간격으로 투여하고, 16주차 이후 8주간격으로 투여함.
 - 9) 신청품군(4주요법)과 신청품군(4주/8주요법) 통합한 결과
 - 10) 신청품군(4주요법)과 신청품군(4주/8주요법) 통합한 결과
 - 11) Reich K, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397:487-98.
 - 12) Reich K, et al. Bimekizumab versus secukinumab in plaque psoriasis. N Engl J Med. 2021;385:142-52.
 - 13) Sbidian E, et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023;7:CD011535.
 - 14) Armstrong AW, et al. Long-term benefit - risk profiles of treatments for moderate-to-severe plaque psoriasis: A network meta-Analysis. Dermatol Ther (Heidelb). 2022;12(1):167-184.
 - 15) 대한피부과학회()
 - 16) 신청품은 생물의약품으로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 % 금액임.
 - 17) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
 - 18) 제약사 제출 예상 사용량
- | 구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 |
|------------|------|------|------|
| 신청품 사용량(펜) | | | |
- 19) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
 - 20) 추가재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × (신청약가 - 대체약제 가중평균가)
 - 21) 대체약제의 경우 초회용법과 유지용법의 차이가 있으나 유지용법 기준으로 산출한 점 등을 고려 시 재정영향은 변동될 수 있음.